

きょうの紙面 ▶ 大腿骨近位部骨折／リハ量 ▶ パーキンソン病／遠隔リハ ▶ 脳卒中／顔面麻痺 ▶ 短信 8本

■ 大腿骨近位部骨折／リハ量

股関節骨折後のリハ未実施55.8% 受けた群は3年死亡リスク17%低下

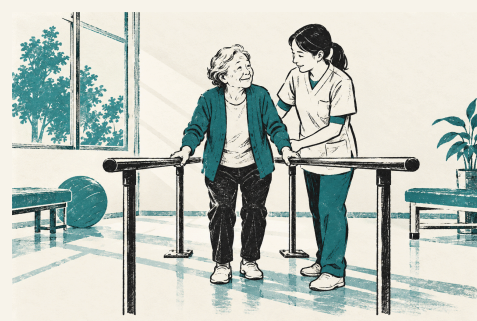
台湾1万人超の後ろ向きコホート 4回以上で0.71、入院から外来へ連続で0.67

台湾の全国健康保険データ（2005～2013年）を使い、大腿骨近位部骨折の初回手術後のリハと3年死亡の関連を調べた後ろ向きコホート研究です。対象は10,142人（平均79.8歳、女性62.7%）で、入院期間は7～10日と短い制度でした。3年間の全死亡は33.2%（3,363人）です。

術後リハを受けていなかったのは55.8%（5,659人）。何らかのリハを受けた群の調整ハザード比は0.83（95%CI 0.77～0.89）でした。経路別では、入院から外来へつないだ群が0.67（0.57～0.79）と最も低く、請求セッション4回以上の群は未実施群と比べて0.71（0.64～0.80）で、量が

多いほど低い傾向がありました。

観察研究のため、元気な人ほどリハを受けた可能性など、交絡は残ります。「回数」は請求上のセッション数で、内容や強度は分かりません。それでも、退院で途切れがちなりハを入院から外来へつなぐ設計と、必要な量を確保する意味を考え



入院から外来へ、リハを途切れさせない設計を考える

る材料になります。

出典 **Clin Rehabil** ↗

数字で見る

55.8%

術後リハを受けなかった割合

0.83

何らかのリハの3年死亡HR

0.67

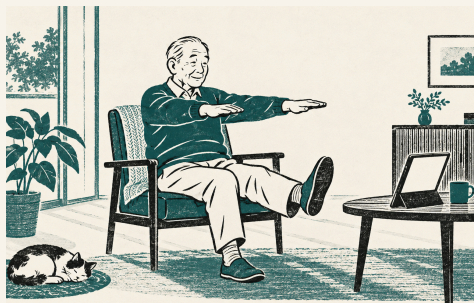
入院～外来の連続リハ群のHR

■ パーキンソン病／遠隔リハ

初期パーキンソン病のAI遠隔リハ 1・2・3か月で運動症状に差なし

中国の多施設で120人（Hoehn-Yahr 2.5以下）を、訓練1・2・3か月の3群に割り付けた評価者盲検RCTです。1日15～30分を週5日行いました。主要評価項目の運動症状（MDS-UPDRS Part III、3か月時点の変化）に、群間差はありませんでした。

最終解析は71人と脱落が多く、通常ケアの対照もありません。認知面の



改善者の割合は3か月群で高かったものの事後解析で、仮説の段階です。転倒や有害事象は記録されず、著者も因果の推論はできないとしています。

出典 **npj Digit Med** ↗

■ 脳卒中／顔面麻痺

脳卒中後の顔面麻痺、測る指標を合意 3領域が初期コアアウトカム案に

2回のe-Delphi（1回目101人・16か国、2回目55人・12か国）と、6か国15人が参加した合意会議で、70%以上が「入れる」とした領域を残しました。合意は、顔の動きと感覚、日常の機能、顔面麻痺とともに生きること、の3領域です。

決まったのは「何を測るか」で、具体的な尺度はこれからです。参加は臨床家と研究者で、当事



者を含む合意形成と尺度の系統的レビューが次の段階です。回復期でも、動きだけでなく日常や生活の受け止めまで見る視点を整理できます。

出典 **Clin Rehabil** ↗

短 信

〈心臓リハ〉短い休息の筋トレは心リハで同等

心血管疾患71人の12週RCT。VO2peakや起立は群間差なし。等速性筋力のみ短休息群が大(+23 vs +11 N・m)。

出典 **Am J Phys Med Rehabil** ↗

〈心臓リハ〉心停止後の心リハ未登録が55%

デンマーク全国登録1,684人。55%が未登録で、登録者の50%が未完遂。退職者で未登録が多い(OR 1.74)。

出典 **Resuscitation** ↗

〈転倒〉脳卒中後の転倒外傷は79.9%

エチオピアの外来269人の横断研究。高齢・農村居住・歩行や方向転換中が外傷と関連。対象は転倒経験者のみ。

出典 **Arch Phys Med Rehabil** ↗

〈大腿骨骨折〉術後に離床が進まない理由

デンマークの病棟観察22回・面接23人。職種ごとの離床観の違いと責任の曖昧さ、疼痛管理が妨げと整理。

出典 **Injury** ↗

〈脊髄損傷〉磁気刺激+ロボットで歩行が改善

慢性不全SCI30人を3群に割付。4週時点で10m歩行などがsham群より改善。2つの刺激法に差なし。小規模。

出典 **Am J Phys Med Rehabil** ↗

〈術後リハ〉腰椎術後の早期離床に電気刺激

ヘルニア術後60人のRCT。早期離床にNMES/TENSを足した群で、ODI・VAS・TUGが改善。単一試験。

出典 **Am J Phys Med Rehabil** ↗

〈栄養〉GLP-1療法と筋肉の減少を整理

ナラティブレビュー。除脂肪量の減少は筋量減少と同じではない。たんぱく質とレジスタンス運動を推奨。

出典 **Diabetes Obes Metab** ↗

〈神経難病〉ALSの在宅緩和ケア1年の経過

パレルモの34人。ALSFRS-Rが27.1→21.7に低下、10人が死亡。事前指示の記録は約7割で頭打ち。単施設。

出典 **Muscle Nerve** ↗